جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : ناهد عبد العزيز جاب الله عمر
المحافظة : الجيزه **الحي / المدينة :** امبابه **العنوان :** 22 ش محمد عرفه
رقم البطاقة : 27811022102907 **رقم التليفون :** 01110058764 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 11-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 02-11-1978 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : أبحاث أورام مسح ذري علي العظام [12966] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: ناهد عبد العزيز جاب الله عمر
National ID: 27811022102907

GUSTAVE ROUSSY INTERNATIONAL EGYPT

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Bone scintigraphy

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية



ناهد
عبدالعزيز جاب الله عمر
٣٢ ش محمد عرفه جزيرة امبابه
امبابه - الجيزه

٢٧٨١١٠٢٢١٠٢٩٠٧

IX5613192

٢٧٨١١٠٢٢١٠٢٩٠٧ ٢٠٢١/٠٦
بدون عمل
أنثى مسلمة
١ البطاقة سارية حتى ٢٠٢٨/٠٥/٣١

Pakistan Program for Women's Health
Ministry of Health and Population

البرنامج الرئيسي لصحة المرأة
وزارة الصحة والسكان

MDT form

A-Patient ID:
1- Name : لاشه عبدالعزيز جد عمر
Sex: Female
3- Medical number: 83048811
Old Med : 3138/2021

2-ID number: 27811022102907
Patient Age : 44 Y

Family history	Family History	Phone	Phone 01110058764	BMI	BMI 21	REASON OF MDT	REASON OF MDT POST OPERATIVE
Marital status	Marital Status	NRS Score	NRS Score 2	GROUP	GROUP	Date of MDT	Date of MDT 3-3-2024
Co morbidity	Co Morbidity	Manopausal status	Menopausal Status PREMENOPAUSAL	Initial STAGE	Initial STAGE		

Breast Imaging :

Meta Workup : CTCAP –>FREE

BX	ER	PR	Her 2 Neu	SISH	KI67
IDC BX COMMENT: GII	8/8 ER COMMENT:	8/8 PR COMMENT:	3 Her 2 Neu COMMENT:	SISH COMMENT :	

T	N	M
4	1	0 BY CT

Sonomammography

PATIENT HISTORY
SM -->PARTIAL RESPONSE
PT ENDED NACT 6TC+6 HP ENDE ON 6/2022
THEN PT MISSED FU UNTIL 5/2023 NOW CT4 N0 M0 BY C T
SO FOR MDT FOR SURGERY: MRM
PATHOLOGY : T0 N0

MDT OUTCOME PLAN
Start Herceptin SC UPTO 17 CYCLES , AI
Check E2 level .. IF pre menopausal , add Zoladex
PORT

MEDICAL ONCOLOGY	MEDICAL ONCOLOGY د/ نجي اسماعيل	RADIOLOGY	RADIOLOGY د/ نبيل حجازي
SURGERY	SURGERY	PATHOLOGY	PATHOLOGY
Psychiatric	Psychiatric	Nutrition	Nutrition

MDT Form
[[DOCTYPE:MDT_FORM]]

Name: ناهد عبد العزيز **MR. :** 2658	

Detailed Medical Report

السيد	

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من		**بشأن تقرير طبي للمريض**	
بقسم:		**رقم طبي:**	

ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول :		**تاريخ وساعة الخروج :**	

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه

The patient has not returned for follow-up since the previous visit, during which the plan was to continue letrozole (Femara) and supportive therapy for three months, and to obtain radiologic imaging and laboratory studies.

The patient is a 47-year-old individual with a past medical history notable for left-sided breast cancer staged as T4b, N1, hormone-receptor positive (ER 8/8, PR 8/8) and HER2-positive (3+). Neoadjuvant chemotherapy with the TCHP regimen was administered for six cycles, achieving a partial response. This was followed by left-sided mastectomy and sentinel lymph node biopsy. Post-operative radiotherapy was completed, and trastuzumab (Herceptin) subcutaneous injections have been continued for up to one year. The patient has been on an aromatase inhibitor (AI) together with goserelin (Zoladex) since February 2024, and the current medication list includes letrozole, goserelin, and supportive therapy for three months. As of the most recent assessment, the patient is disease-free on physical examination. The plan is to continue letrozole, goserelin, and supportive therapy as prescribed.

تحريرا في ,

التاريخ :	19-09-2026	**الوقت :**	
الطبيب المعالج :	Ali Adel		

يعتمد ,

Ministry of health
Central health laboratories
Pathology department

Histopathology report

Report Number: 625

اسم المريض	: ناهد عبدالعزيز جاب الله	النوع :	Female
السن	: 42 Y	العنوان :	القاهرة
تاريخ اخذ العينة	:	تاريخ استلام العينة :	07/10/2020 12:30
طالب التحليل	: مركز صحه المرأة	تاريخ التقرير :	12/10/2020 12:57
عناية	: مركز صحه المرأة		

Primary sample :

breast core biopsy

comment :

Gross examination :

4 cores of greyish white tissue (T.I)

Microscopic examination :

section examined revealed fibrocollagenous tissue infiltrated by malignant growth displaying the morphology of infiltrating duct carcinoma

Referal Lab :

Comment :

Diagnosis :

BREAST CORES: THE PICTURE IS COMPATIBLE WITH INFILTRATING DUCT CARCINOMA, GII

Pathologist: Dr\Jehan Aziz

Lab Director: د/ تريزا ماهر

19 El-sheikh Rehan Street, Abeideen, Cairo
Tel.(165)7948544 -7950096 Fax. (202)7948544
Mobile . 01144297292
website:http://www.healthlabs.net
email:pahologych!@yahoo.com
facebook قسم الباثولوجى - الادارة المركزية للمعامل

This Test Is Not Accredited By EGAC Nor Recognized By ILA

يتم الاحتفاظ بأصل العينة لمدة 30 يوم من تاريخ استلامها

Cairo University
National Cancer Institute
Department of Diagnostic and
Interventional Radiology

جامعة القاهرة
المعهد القومي للأورام
قسم الأشعة التشخيصية والتداخلية

Exam Information:	
Patient Name: NAHD Abdullaziz	Date of birth: 02/11/1978
Arabic Name: ناهد عبدالعزيز	Patient Gender: F
Patient RIS ID: 334336	Exam Date: 15/08/2023
Patient HIS ID: 123016590	
Written by: Dr. Hoda Fathy	Approved by: Dr. Hoda Fathy

^{99m}Tc MDP Bone Scan Report (14-08-2023)

Whole Body Anterior and Posterior Planar Views Acquired 2Hrs. Post I.V Injection of 20mCi of ^{99m}Tc MDP

Revealed:

No definite evidence of active osseous deposits could be seen over the surveyed skeleton.

Degenerative changes are noted over the dorsolumbar vertebrae.

Mild arthritic changes are noted over both shoulder and both knee joints.

Both kidneys are visualized.

Conclusion:

No definite evidence of active metastatic osseous deposits could be seen all over the surveyed skeleton.

Much Obliged

Rawan Mohamed

Dina Thabet

Dr. Nada Fadl, MSc

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

وزارة الصـــــحة والسكـــان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام
ادارة الاشعة

Patient Name: Nahed Abd Al Aziz Gab Allah Omar	Date: 30/04/2023
Exam: ultrasound BREAST (BOTH SIDE)	Age: 44 Year(s)
Medical ID: 3138/2021	Pat ID: 14641

Combined bilateral breast mammography and complementary ultrasound

Indication:

left breast pathologically proven malignant mass on NACT for assessment.

Technique

- Bilateral MLO and CC views
- Bilateral breast ultrasound

Report:

- (ACR C)
- Left breast shows LIQ spiculated irregular mass lesion with suspicious clustered microcalcifications within.
- Complementary ultrasound revealed left breast irregular spiculated isoechoic mass lesion, seen at 7 o'clock abutting chest wall measures 1.5 x 2.7 cm compared to 2 x 3.5 cm.
- No right breast solid or cystic masses.
- Normal skin thickness, and nipple-areola complex of the right breast.
- Nonspecific axillary LN, bilaterally
- Free left infra and supra-clavicular regions.

Opinion:

- Partial radiological response of the left breast UOQ malignant mass (BIRADS 6)
- Benign findings right breast (BIRADS 2)

Yours truly

Signature Dr. Aya Deabes

30/04/2023 4:53 PM

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام
ادارة الاشعة

Patient Name: Nahed Abd Al Aziz Gab Allah Omar	Date : 30/04/2023
Exam : C.T CHEST	
Medical ID:	Age : 44 Year(s)
	Pat. ID: 14641

NON-CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST: -

Findings:

- Left breast LIQ irregular mass is seen underlying focal skin thickening.
- Right fissural tiny pulmonary nodule is seen measuring about 4 mm, likely insignificant.
- No hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- No gross cardiac abnormality. No pericardial effusion detected.
- Normal appearance of the chest wall.
- Upper abdominal cuts are unremarkable.

OPINION:

- ***No CT evidence of active pneumonia.***

Signature Prof. Menna Tallah Hanafy

01/05/2023 03:00

CT Scan
[[DOCTYPE:CT;SCAN]]

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام
ادارة الاشعة

Patient Name: Nahed Abd Al Aziz Gab Allah Omar	Date : 30/04/2023
Exam : C.T CHEST	Age : 44 Year(s)
Medical ID:	

NON-CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN & PELVIS REVEALED: -

****A known case of left breast cancer.***

1. ***Chest:***

- Apart from right transverse fissural based micro-nodule, otherwise, no pulmonary masses, nodules or consolidations.
- No pathological hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Average cardiac size. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.

2. ***Abdomen and pelvis:***

- The liver is average in size with homogenous CT texture. No definite focal lesions or biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- No pathological abdominal or pelvic lymph nodes.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both supra-renals.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- No abdominal or pelvic masses or collections.

3. ***The scanned skeleton:***

- The scanned skeleton shows no definite worrisome lytic or sclerotic lesions.
- No vertebral structural collapse or extra-osseous soft tissue component.

OPINION:

- ***No definite pulmonary, hepatic or osseous metastatic deposits on non contrast basis.***

Dr. Amr Farouk, M.D.

EL KATIB
BREAST CENTER
CENTER OF EXCELLENCE
Operated By: ABC

Operated By:
ABC
abc

السيد الأستاذ الدكتور/ مدير الغرفة المركزية لإنهاء قوائم الانتظار – وزارة الصحة و السكان

تحية طيبة و بعد

مرسل لسيادتكم التقرير الطبي بالعملية الجراحية الخاصة بالمريضة :

ناهد عبدالعزيز جاب الله عمر رقم قومي: 27811022102907

و ذلك في إطار برنامج وقاية لانهاء قوائم انتظار جراحات أورام الثدي وذلك بتعاون من مؤسسة شريف عمر لعلاج الأورام و مجموعة مستشفيات كليوباترا و شركة أورنج مع التأكيد على عدم تحمل المريضة لاية تكاليف او مصروفات.

مع خالص الشكر و التقدير

ا.د.عمر شريف عمر
رئيس مؤسسة شريف عمر لعلاج الأورام – وقاية
أستاذ الجراحة – مدير وحدة جراحات أورام الثدي – القصر العيني

Medical Report

The above mentioned 45 years old presented to our Oncoplastic Breast Surgery Outpatient Clinic at El Katib Hospital – Cleopatra Hospital Group on the 4th of January 2024 with MDT decision for Left MRM.

After performing the necessary preoperative assessment, the patient was planned for surgery on the 7th of January, The patient was operated with a smooth intraoperative course.

The patient was discharged on the next day of Surgery and was seen in the breast surgery follow up clinic with timely removal of the drains and stitches. The case was also seen at the post operative lymphedema prevention clinic and was given the proper instructions. Moreover the patient was also seen postoperatively at the Breast Psychology Clinic with overall good medical and mental wellbeing.

Postoperative pathology revealed :
- Totally Burnt out tumor .
- No Residual Malignancy (RC8-0)
- Free Nipple And Areola .
- Free And Adequate Resection Margins
- Free Axillary Lymph Nodes (0/11).

Much appreciated

Prof Omar Sherif Omar
Director - Breast Center Of Excellence
El Katib Hospital - CHG

orange